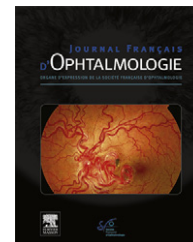




Disponible en ligne sur
 ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

www.em-consulte.com



ENTRETIENS ANNUELS D'OPHTALMOLOGIE / *Les taches oculaires suspectes*

Taches oculaires suspectes. Avant-propos

Suspicious pigmented lesions. Foreword

P. Gastaud*, J.-P. Caujolle

Service d'ophtalmologie, CHU Saint Roch, Nice

Disponible sur Internet le 21 janvier 2010

Les taches pigmentées de l'œil regroupent trois sortes de pathologies bien différentes. Les taches palpébrales et les taches conjonctivales pour lesquelles, au moindre doute, une prise en charge chirurgicale permet de porter un diagnostic histologique précis ; les taches intra-oculaires pour lesquelles la biopsie reste d'utilisation exceptionnelle pour le diagnostic.

En ce qui concerne les taches pigmentées des paupières, les nombreuses campagnes d'information effectuées par les dermatologues ont porté leurs fruits et il est heureusement rare aujourd'hui de constater des thérapeutiques inadéquates.

Il en est autrement des taches conjonctivales. Trop souvent encore, l'ophtalmologiste imagine que tout sera résolu par son geste chirurgical qui semble avoir fait le plus difficile : le diagnostic ! Cependant, notion fondamentale fréquemment ignorée en cas de malignité d'une tumeur conjonctivale, il est impératif de mettre en œuvre des thérapeutiques complémentaires sous peine de récurrences dans plus de 50 % des cas et de l'effondrement du pronostic vital.

En raison de l'absence de document histologique, les taches intra-oculaires interpellent le praticien qui aura tendance à faire appel à un spécialiste de la

cancérologie oculaire. Le plus souvent, l'expérience de l'onco-ophtalmologiste référent permet un diagnostic grâce à l'analyse sémiologique clinique et aux examens de base que constituent l'angiographie et l'échographie. Toutefois, le suivi strict de l'évolution de certaines de ces lésions traitées ou non traitées est souvent nécessaire et fait appel à des règles qu'un ophtalmologiste doit connaître, car c'est souvent lui qui assurera une grande partie de cette surveillance. De même, rôle ingrat, il devra s'assurer de la régularité de ces contrôles, car trop souvent encore, des patients sont examinés avec un mélanome évolué alors qu'un diagnostic de tache suspecte à surveiller avait été porté quelques années auparavant.

Malgré nos moyens techniques de plus en plus évolués, il est grave de constater actuellement dans les services de cancérologie oculaire que la taille moyenne des tumeurs cancéreuses traitées n'a jamais été aussi élevée ! Cela est sans doute lié à la baisse démographique des ophtalmologistes et donc au manque de temps parfois consacré à l'examen de certains patients. Il est donc important de connaître les approches diagnostiques et thérapeutiques des pathologies décrites dans les exposés qui vont suivre et qui ont fait l'objet d'une session entière des Entretiens Annuels d'Ophtalmologie en mai 2008. Il faut garder à l'esprit que tout retard de prise en charge d'une tumeur maligne, redoutée devant une lésion oculaire pigmentée, se traduira invariablement par une diminution des chances de survie du patient.

* Auteur correspondant. Service d'ophtalmologie, CHU Saint Roch, 5, rue Pierre Devoluy, 06000 Nice Cedex 1, France.
Adresse e-mail : gastaud.p@chu-nice.fr (P. Gastaud).